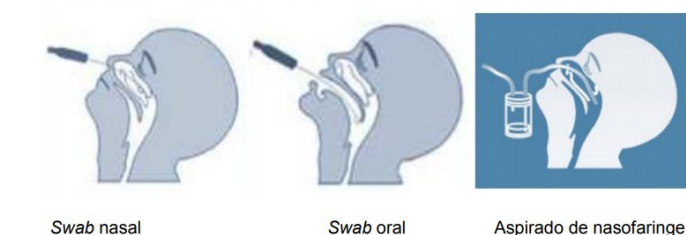


Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Rotina	Versão	Página
03/04/2020	03/04/2020	03/04/2022	03/04/2022	Nº 29	Nº 02	01 de 04
Nome do procedimento: Coleta de SWAB combinado (nasofaringe e orofaringe)						
Área: Unidades de Pronto Atendimento – UPA Leste / UPA Sul / PA Norte			Setor: Enfermagem e Medicina			
Executantes: Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos						
Objetivo: Detectar vírus respiratório COVID-19, influenza A e B, adenovírus, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, parainfluenza tipos 1, 2, 3.						
Recursos necessários:						
• SWAB de nylon ou rayon, flexível, estéril com haste de plástico fornecido pelo LACEN/SC; • Meio de Transporte Viral (MTV) ou solução estéril de PBS 7,2 suplementado; • EPIs para coleta (colocar nessa ordem: avental descartável, máscara N95, gorro, óculos / <i>face shield</i> e luvas de procedimento); • Lenço de papel; • Tesoura; • Marcador; • Etiqueta para identificação; • Lixeira para descarte de material infectante; • Caixa de isopor ou caixa térmica; • Bobinas reutilizáveis (gelox); • Embalagem secundária; • Solução alcoólica; • Toalha de papel.						
Descrição:						
a) Coleta de SWAB combinado (nasofaringe e orofaringe)						
<u>Técnica de coleta:</u>						
• Higienizar as mãos antes do procedimento; • Realizar a paramentação para coleta do procedimento; • Orientar o paciente quanto ao procedimento a que será submetido; • A coleta de SWAB combinado é realizada em nasofaringe e orofaringe. Um SWAB é inserido em orofaringe e os outros dois em cada narina. O SWAB utilizado deve ser de nylon ou rayon e não utilizar SWAB de algodão, com haste de madeira e/ou alginato de cálcio, uma vez que interferem nas metodologias moleculares; • Examinar a fossa nasal do paciente, a fim de verificar a presença de secreções e a posição dos cornetos médio e inferior. Quando na presença de secreções, pedir ao paciente para assoar (limpar) o nariz. O SWAB tem como objetivo a coleta de um esfregado de células e não secreção nasal;						

- A coleta deve ser realizada na região posterior do meato nasal para obtenção de células da mucosa, com movimento de rotação, de forma a evitar o sangramento nasal;
- Introduzir o SWAB na cavidade nasal em um ângulo aproximado de 30° a 45° em relação ao lábio superior (Figura 01);
- Remover o coletor do nariz do paciente de maneira cuidadosa, feito isto introduzir, imediatamente, no tubo com solução estéril;
- Após a coleta do SWAB nasal, realizar a coleta do SWAB de orofaringe introduzindo o SWAB até a parede posterior da orofaringe, realizando movimentos de rotação para obter células da mucosa, evitando tocar em dentes, língua e bochecha (Figura 1) introduzir, imediatamente, no tubo com solução estéril;
- Remover o coletor da orofaringe cuidadosamente, sem que tenha contato com outras regiões da boca;

Figura 01 – Técnica de coleta de SWAB combinado e aspirado de nasofaringe



Fonte: BRASIL, 2014

- Inserir as três coletas de SWAB em um mesmo frasco com solução MTV (meio de transporte viral) cedido pela Vigilância Epidemiológica (o mesmo disponibilizado para o diagnóstico de influenza);
- Quebrar ou cortar o excesso de hastes do SWAB;
- Identificar o frasco MTV com nome completo e data de nascimento do paciente, de forma legível;
- Colocar o frasco MTV dentro de um recipiente plástico secundário e identificá-lo com nome completo e data de nascimento do paciente, de forma legível;
- Retirar EPI na seguinte ordem: luva e lave as mãos, avental e lave as mãos, gorro, óculos e lave as mãos, máscara N95 e lave as mãos (descarte nessa mesma sequência os itens no lixo infectante);
- Calce luvas e encaminhe amostra para ser acondicionada para transporte;
- Finalizado coleta, seguir orientação conforme “Acondicionamento para transporte”.

b) Coleta de aspirado de nasofaringe (ANF)

- Utilizar a Técnica de Aspirado de Nasofaringe **quando a Unidade de Saúde dispuser de frasco coletor de secreção***. Esta técnica permite concentrar maior número de células;

*frasco coletor de plástico descartável e com controle de vácuo (tipo bronquinho). Não havendo, a coleta será realizada com a técnica de *SWAB combinado*.

A coleta de ANF é um processo indolor podendo apenas provocar lacrimejamento reflexo. Coletores de muco descartáveis ou equipo de soro acoplado a uma sonda são preferencialmente recomendados para a obtenção do espécime. A sonda preconizada é a uretral nº 6 com apenas um orifício na ponta. O calibre da sonda é variável segundo o fabricante, devendo ser dada preferência à de maior flexibilidade. A aspiração pode ser realizada com bomba aspiradora portátil ou bomba a vácuo de parede do hospital; evitar pressão de vácuo muito forte.

Técnica de coleta:

- Higienizar as mãos antes do procedimento;
- Inserir através da narina até atingir a região da nasofaringe quando então o vácuo é aplicado aspirando a secreção para o interior do frasco coletor ou equipo. O vácuo somente é acionado quando a sonda estiver na nasofaringe. Este procedimento deve ser realizado em ambas as narinas, mantendo movimentação da sonda para evitar que haja pressão diretamente sobre a mucosa provocando sangramento (Figura 01);
- Alternar a coleta nas duas fossas nasais até obter um volume suficiente, aproximadamente 1 mL de ANF;
- Após nebulização com soro fisiológico a secreção é mais fluida e abundante, facilitando a obtenção. Não insistir se a coleta não alcançar o volume desejado (mais ou menos 1 mL), pois poderá ocasionar lesão de mucosa;
- Após aspirar a secreção nasofaríngea com o coletor próprio, inserir a sonda de aspiração no frasco contendo 3 mL de meio de transporte viral (MTV) ou em PBS pH 7,2 (fornecido pela Vigilância Epidemiológica) e aspirar todo o meio para dentro do frasco coletor;
- Fechar o frasco coletor e identificar com nome completo e data de nascimento do paciente, de forma legível;
- Colocar o frasco dentro de um recipiente plástico secundário, identificando-o com nome completo e data de nascimento do paciente, de forma legível;
- Retirar EPI na seguinte ordem: luva e lave as mãos, avental e lave as mãos, gorro, óculos, lave as mãos, máscara N95 e lave as mãos (descarte nessa mesma sequência os itens no lixo infectante);
- Calce luvas encaminhe amostra para ser acondicionada para transporte;
- Finalizado coleta, seguir orientação conforme “Acondicionamento para transporte”.

c) Acondicionamento para transporte:

- É proibido colocar a caixa de transporte da amostra (caixa de isopor ou térmica) no mesmo ambiente onde será realizado a coleta do swab. A caixa deve permanecer em outra sala, e receber a amostra (já na embalagem secundária devidamente lacrada) somente quando for se realizar o transporte já devidamente preparada;
- Se transporte não for imediato, a embalagem secundária, devidamente lacrada, poderá ser colocada em geladeira específica para esse fim, até o momento do transporte. Fica proibida a utilização dessa geladeira para qualquer outro fim;
- Quando do transporte, acondicionar a embalagem secundária dentro da caixa de isopor com bobina reutilizável (gelox) de forma que o mesmo não vire;
- Manter refrigerado em caixa de isopor entre 4°C e 8°C durante o período de armazenamento e transporte. Certifique-se de colocar bobina reutilizável (gelox) suficiente para isso. Sugere-se de 2 a 3 unidades;
- Após a coleta comunicar Vigilância Epidemiológica;
- Encaminhar ao LACEN/SC através da Vigilância Epidemiológica.

Observações:

- Nos pacientes em ventilação mecânica coletar preferencialmente secreção traqueal, utilizando o calibre da sonda compatível à idade;
- Diante de um caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, amostras de secreção de nasofaringe e/ou orofaringe poderão ser coletadas para detecção de vírus respiratório;
- A coleta em pacientes com síndrome gripal deve ser realizada SOMENTE nas Unidades Sentinela mediante a presença da tríade de queixas (tosse produtiva, febre e cefaleia ou

mialgia), cuja meta de coleta é de cinco casos de síndrome gripal por semana em cada Unidade Sentinela;

- A coleta em pacientes com suspeita de COVID-19 deverá ser realizada seguindo os critérios da Vigilância Epidemiológica. Se houver restrição de insumo (swab) utilizar um swab na narina direita e posteriormente o mesmo na narina esquerda para coleta de secreção da nasofaringe e um segundo swab para coleta da secreção de orofaringe;
- A amostra clínica do paciente deverá ser coletada **até o 7º dia após o início dos sintomas**, não ultrapassando este período;
- Seguir fluxo da Vigilância Epidemiológica vigente quanto ao horário de encaminhamento da amostra;
- Amostras que não se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Vigilância Epidemiológica não serão processadas pelo LACEN/SC, salvo exceções avaliadas pela SES/Joinville.

NOTA: Para demonstração do Procedimento de Coleta de Swab, acesse: <https://vimeo.com/403760930>

REFERÊNCIAS:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: volume único [recurso eletrônico]. **Orientações para coleta, armazenamento, transporte e envio de amostras para diagnóstico laboratorial de influenza**. 3ª edição. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2019.
2. ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Laboratório Central de Saúde Pública. **Manual de orientação para coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas**. Florianópolis – SC: 2017. Disponível em: < <http://lacen.saude.sc.gov.br/arquivos/MCT01.pdf> >
3. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Instituto de Pesquisas Biológicas. Laboratório Central de Saúde Pública. Seção de Virologia – Laboratório de Vírus Respiratórios. Investigação da Influenza Humana. **Orientações para coleta e transporte de secreção respiratória – 2017**. Porto Alegre – RG: 2017. Disponível em: <<http://www2.ebserh.gov.br/documents/219273/2154790/orientacoes-para-coleta-e-transporte-de-secrecao-respiratoria-2017-1.pdf/47b3f12a-3bd7-4196-ab5f-cc39b62018df> >

Elaborado por: Kamila Santos Trierveiler	Revisado por: Luciana Gai Débora Galle Moraes	Aprovado por: Renata Andrade Teixeira Heil
Acesso Plataforma SEI DRIVE SES/Joinville	Disponível pelo Endereço Eletrônico: Processo 20.0.049852-8 https://bit.ly/covid-19joinville	

Alterações após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	16/04/2020	Renata A. T. Heil	- Autoriza utilização de geladeira; - Retira orientação sobre quando encaminhar para Vigilância Epidemiológica; - Orienta quando houver escassez de insumo (swab); - Alteração da data de coleta.